جمهورية العراق

وزارة الصحة – دائرة الصحة العامة

دليل مكافحة التبغ في الرعاية الصحية الاولية

للملاكات الطبية والصحية العاملة في مراكز

الرعاية الصحية الاولية الرئيسية



شعبة مكافحة التبغ

قسم الوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية

الطبعة الثانية

2024

دليل مكافحة التبغ في الرعاية الصحية الاولية

مبادئ توجيهية مبسّطة للملاكات الطبية والصحية العاملة في الرعاية الصحية الاولية

الاشراف العام
الدكتور رياض عبد الامير الحلفي
مدير عام دائرة الصحة العامة

اعداد وتصميم وتنفيذ
د. عباس جبار صاحب
طبيب استشاري
مدير شعبة مكافحة التبغ

المراجعة
(اللجنة الفنية المشكلة في وزارة الصحة)

د. منى عطا الله خليفة علي
طبيبة استشارية
مدير قسم الوقاية والسيطرة على
الامراض غير الانتقالية

د. وسيم كيلان شاكر
رئيس اطباء اختصاص
مسؤول وحدة الاتصال والتدريب
والتوعية المجتمعية/ شعبة مكافحة التبغ

د. ميسرة حسين كمونة
رئيس اطباء اسنان اقدم
مسؤولة وحدة خدمات الاقلاع عن
التدخين/ شعبة مكافحة التبغ

د. نور محمد علي وحودي
طبيبة اختصاص
قسم الاعلام

د. نجوى يونس داود
طبيبة اسنان ممارسة
قسم المراكز الصحية وصحة الاسرة

د. سنان عصام عبد الرزاق
طبيب احتصاص
قسم تعزيز الصحة

فرح مازن عبد الحسين
مشاور قانوني مساعد
وحدة رصد الاستراتيجية الوطنية
لمكافحة التبغ/ شعبة مكافحة التبغ

ايمان عباس سلمان
ماجستير اعلام
وحدة الاتصال والتدريب والتوعية
المجتمعية/ شعبة مكافحة التبغ

محتويات الدليل

الموضوع	رقم الصفحة
اهداء	3
مقدمة	4
نبذة تاريخية	5
وبائية التبغ في العالم	7
وبائية التبغ في العراق	9
اشكال منتجات التبغ	10
اضرار التبغ الاضرار الصحية التدخين السلبي واضراره الاضرار البيئية الاضرار الاقتصادية	15 15 23 24 26
التزامات العراق الدولية في مجال مكافحة التبغ	27
التزامات العراق الوطنية في مجال مكافحة التبغ	28
مكافحة التبغ في الرعاية الصحية الاولية	29
المداخلات المبسّطة للتحرر من التبغ (5A)	34
خدمات الحماية من اضرار التبغ (3A)	35
خدمات الاقلاع عن التدخين (2A)	36
ماذا يحدث للجسم عند ترك التدخين	37
الخطوات العشر للمساعدة على الاقلاع عن التدخين	38
العقاقير المستخدمة عالمياً للاقلاع عن التدخين	42
الاعراض الانسحابية لترك التدخين	42
النيكوتين وعلامات التسمم به	43
عقار البوبروبيون Bupropion	44
لصقات النيكوتين الجلدية Nicotine patches	45
علكة النيكوتين Nicotine gum	46
اقراص المص (النيكوتين) Nicotine lozenges	47
مشروع المدارس المناهضة للتدخين	48
رسائل صحية عن التدخين	49
المصادر	50

اهداء

الى الارواح التي ارتقت سلّم المجد والخلود لتعانق ملائكة السماء بعد ان لبّت نداء الواجب لترسم

لنا اجمل صورة عن معاني التضحية والفداء والجود والكرم

الى ملائكة الرحمة على الارض الذين جادوا بانفسهم لنحيا نحن وابناءنا

اليهم ... نوقد الشموع

الى شهداء الجيش الابيض في مؤسساتنا الصحية كافة وخاصة العاملين في الرعاية الصحية الاولية

نهدي هذا العمل المتواضع



مقدمة

يعتبر التدخين واحدا من اهم المشاكل التي تواجه مجتمعات العالم صحياً واقتصادياً واجتماعياً وهو متزايد في الانتشار خاصة لدى فئة الشباب واليافعين من كلا الجنسين الذكور والاناث .
لقد ثبت بالدليل القاطع والبرهان الساطع ان التبغ مضر بأشكاله كافة، وان ضرره يتعدى الجانب الصحي فهو يساهم بحدوث اضرار بيئية واجتماعية واقتصادية كبيرة ولايقتصر ضرره على المدخن فقط بل يتعدى ذلك ليشمل المحيطين به (التدخين السلبي) .

وفقاً لاحصائيات منظمة الصحة العالمية، يقدّر عدد المدخنين الموجودين حالياً في العالم بحوالي 1,3 مليار مدخن، معظمهم (اكثر من 80%) من سكان الدول النامية حيث يقتل التبغ مايقارب من 8 مليون مدخن سنويا وإذا مااستمرت معدلات الاستهلاك الحالية على وتيرتها، فيُتوقع ان تزداد أعداد الوفيات بشكل مضطرد خلال السنوات القليلة القادمة.

يتسبب التدخين السلبي بوفاة اكثر من مليون وربع المليون شخص سنوياً من غير المدخنين (بسبب تعرضهم لدخان التبغ في الاماكن العامة المغلقة)، منهم اكثر من 165000 (مائة وخمسة وستون الف) من الاطفال، كما انه المسؤول عن وفاة مئات الالاف من الاشخاص في اماكن العمل مما يعكس الضرر الكبير الذي يلحق بغير المدخنين جراء تعرضهم لدخان الاخرين.

عكفت وزارة الصحة ومنذ أمد بعيد على وضع الخطط والبرامج الفعّالة والهادفة الرامية لمكافحة وباء التبغ بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات ذات العلاقة خاصة بعد المصادقة على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة التبغ عام 2007 وصدور قانون مكافحة التدخين عام 2012.
تلعب المؤسسات الصحية دوراً هاماً وكبيراً في حماية المجتمع من مخاطر التدخين و توجيه سلوكيات الاشخاص نحو نبذ هذه العادة الخطيرة من خلال الاستمرار بنشر الوعي الصحي بالاضرار الجسيمة الناجمة عن تعاطي التبغ والتعرض لدخانه وتنفيذ البرامج العالمية على مستوى الرعاية الصحية الاولية ومنها المداخلات المبسّطة للتحرر من التبغ (5A) والتي تهدف الى مساعدة المدخنين الراغبين بالاقلاع عن التدخين، وبناءً على ذلك قامت شعبة مكافحة التبغ في قسم الوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية باصدار الطبعة الاولى من دليل مكافحة التبغ في الرعاية الصحية الاولية عام 2018 ، وبسبب تسارع وتيرة الاحداث في مجال مكافحة التبغ عالمياً ومايرافق ذلك من تغييرات في البيانات والاحصائيات، تم اصدار الطبعة الثانية من الدليل ليواكب التطورات والمستجدات العالمية والاستفادة منه في تدريب العاملين في الرعاية الصحية الاولية.
متضرعين الى الله عز وجل ان يؤيد مساعي العاملين في هذا المجال لدرء الخطر عن المجتمع وتقليل نسب المراضة والوفاة المتعلقة باستخدام منتجات التبغ ...
ومن الله التوفيق.

نبذة تاريخية



يعود تاريخ زراعة التبغ إلى القارة الأمريكية حيث استخدمها السكان الأصليون (الهنود الحمر) في طقوسهم الدينية باعتبارها مسكنًا للأوجاع وطاردةً للارواح الشريرة حيث تصف بعض اللوحات الأثرية المنحوتة رقص المحاربين الهنود حول كهنتهم الذين ينفخون الدخان عليهم ليحثوهم على القتال والصمود في المعارك، بدأ تاريخ ظهور التبغ مع اكتشاف العالم الجديد سنة 1491 من قبل كريستوفر كولومبوس إذ لاحظ هذا الرحالة وبحارته أن هنود الأوراك في جزيرة سان سلفادور وهنود الجزر الغربية يحرقون أوراق التبغ في أنبوب يشبه الغليون ويستنشقون الدخان من خلال فتحات أنوفهم كما استعملوه في شعائرهم الدينية، بعدها احضره البحارة معهم عند عودتهم إلى أوروبا ليتمكنوا من زراعته واستخدامه لاغراض مختلفة.

في القرن التاسع عشر صمّم الفرنسيون ورق التبغ صانعين بذلك أول سيجارة في التاريخ، ومع اختراع السجائر بدأ انتشار التبغ في اوروبا ومنها الى بلدان العالم الاخرى حيث بدأت الشركات تروّج للسجائر وتبيعها للعامة وتتخذ منها تجارة رابحة.

نبات التبغ

عبارة عن نبات عشبي حولي من الفصيلة الباذنجانية Solanaceae غني بالنيكوتين، يزرع في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية والمعتدلة للحصول على أوراقه التي يصنع منها السجائر والسيجار والنشوق (سعوط) والمضغة بعد تجفيفها وتخميرها. تتباين مناطق زراعته في اكثر من 120 بلداً كالصين والهند وتايلند ولبنان وفيتنام وكينيا وبلغاريا وايطاليا وتركيا واليونان وامريكا الشمالية بالاضافة الى البرازيل والارجنتين في امريكا الجنوبية.



وبائية التبغ في العالم

- قتل التبغ 100 (مائة) مليون شخص خلال القرن الماضي ومن المتوقع ان يقتل مليار شخص خلال القرن الحالي.
- تجاوز عدد المدخنين في العالم (1.3) مليار مدخن، اكثر من (80%) منهم يعيشون في البلدان النامية.
- يموت (8) مليون شخص في العالم سنوياً لاسباب تتعلق باستخدام التبغ وهو ما يفوق عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير والمخدرات والكحول والايدز وحوادث الحريق مجتمعةً.
- يقتل التدخين السلبي اكثر من مليون وثلاثمائة الف شخص في العالم سنوياً من غير المدخنين، منهم 300000 (ثلاثمائة الف) في اماكن العمل فقط.
- نصف اطفال العالم يعيشون في اسر احد افرادها (على الاقل) من المدخنين.
- تقلل السيجارة الواحدة حوالي (7) دقائق من عمر الشخص المدخن.
- يقتل التبغ شخصاً واحداً من كل اثنين من مستخدميه.
- الخطر الناجم من تدخين الاركيلة لمدة ساعة واحدة يعادل الخطر الحاصل من تدخين (100-200) سيجارة.
- التدخين مسؤول عن 12% من الوفيات الناجمة عن الامراض غير الانتقالية في العالم.
- التدخين مسؤول عن 20% من الوفيات الناجمة عن الاصابة بأمراض القلب والاوعية الدموية
- التدخين مسؤول عن 42% من الوفيات الناجمة عن الاصابة بالأمراض التنفسية المزمنة.
- التدخين مسؤول عن 85% من الوفيات الناجمة عن سرطان الرئة.
- من بين كل 10 مدخنين، 9 يبدأون هذه العادة السيئة قبل بلوغهم سن الـ 18 عام.
- يزداد استهلاك التبغ بين الفتيات بشكل كبير حول العالم، وأن معدل الانتشار في الكثير من الحالات، مشابه بل وحتى أعلى من مثيله لدى الفتيان في بعض بلدان العالم.
- اكثر من 38 مليون شخص في العالم بعمر 13 – 15 سنة يدخنون التبغ وهم في ازدياد.
- تحتوي السيجارة الواحدة على 7 الاف مادة كيميائية سامة، منها النيكوتين (المادة المسببة للادمان) والقطران واول اوكسيد الكاربون واكثر من 70 مادة مسرطنة كالزرنيخ والبريليوم والكادميوم والكروم والكوبالت والرصاص والنيكل والعناصر المشعة المسرطنة كاليورانيوم.

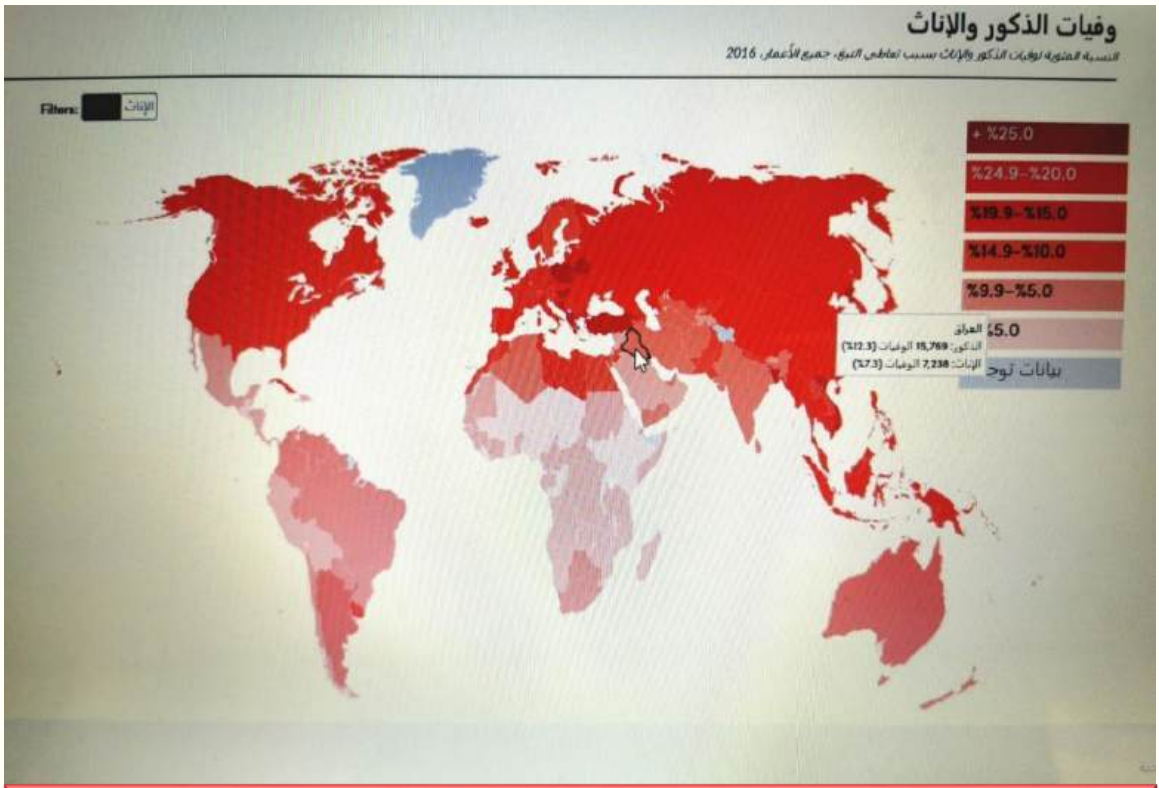




تدخين الاركيلة (الشيشة) لمدة ساعة واحدة يعادل الضرر الحاصل من تدخين 100- 200 سيجارة

وبائية التبغ في العراق

- ❖ وفقاً لمسح عوامل خطورة الامراض غير الانتقالية الذي اجرته وزارة الصحة عام 2015 بلغت معدلات تعاطي التبغ لدى البالغين (ممن هم بعمر 18 سنة فأكثر) 20.7% (38% رجال و1.9% نساء)
- ❖ معدلات تعاطي التبغ لدى الشباب (13-15) سنة بحسب المسح العالمي للشباب لعام 2019
  - 14.8% من الطلاب يدخنون التبغ (18.7% ذكور و 10.4% من الأناث)
  - 8.1% من الطلاب يدخنون السجائر (11.5% ذكور و 4.5% أناث)
  - 7.5% من الطلاب يدخنون الاركيلة (8.9% ذكور و 6 % أناث)
  - 7.5% من الطلبة يدخنون السيجارة الالكترونية (10.6% ذكور و 4.1% اناث)
  - 44.8% من الطلاب يتعرضون الى دخان التبغ في بيوتهم



تقدر منظمة الصحة العالمية عدد الوفيات في العراق لأسباب تتعلق باستخدام التبغ بوفاة واحدة كل 20 دقيقة

اشكال منتجات التبغ



التبغ المدخن Smoked tobacco

وهو التبغ الذي يتم استخدامه عن طريق الاحتراق ويشمل:
السجائر، السيجار، الاركيلة (الشيشة)، الغليون (البايب) وغيرها.

التبغ غير المدخن: Non smoked tobacco

وهو خليط من نيكوتين التبغ والسكر والملح وهيدروكسيد الكالسيوم وبعض التوابل والمنكهات وقد تطلق مئات المواد الكيميائية والسمية عند استخدامها ويشمل:

- **تبغ المضغ: Chewing Tobacco** تاتي عادة على شكل اوراق او مضغة توضع داخل تجويف الفم وعلى جهة الخد من الداخل تؤدي الى افراز الكثير من اللعاب وينتهي الامر بالمستخدمين عادةً ببصقها خارج الفم.
- **تبغ الشم او الاستنشاق (العاطوس، النشوق): Snuff**
- **التبغ الرطب: Snus** يأتي عادةً على شكل بودرة رطبة او معبأ في اكياس صغيرة يضعه المستخدم تحت الشفة العليا او السفلى من الداخل.







التبغ المسخن: Heated tobacco products (HTP) وهو من المنتجات التبغية الناشئة او الحديثة التي بدأت بالانتشار السريع في السنوات الاخيرة يتكون من جهاز الكتروني واعواد تبغ (لفافات ورقية تحتوي على التبغ شبيهة بالسجائر الاعتيادية) حيث يتم استخدام حرارة عالية تصل إلى 350 درجة مئوية لتسخين اعواد التبغ (وليس حرقها) لينتج عنها هباء جوي او ضبوب مشبع بالنيكوتين مع انبعاث عدد كبير من المواد الكيميائية السامة ويتم اضافة النكهات الى هذه المنتجات ما يساعد على جذب الشباب واغرائهم على استخدامه.

وهنا ينبغي التفريق بين التبغ المسخن ووسائل ايصال النيكوتين الكترونياً Electronic Nicotine Delivery System (ENDS) كالسجائر الالكترونية والشيشة الالكترونية التي تحتوي على "سوائل إلكترونية" يحولها الجهاز إلى بخار يستنشقه المستخدم، عكس التبغ المسخن الذي يقوم على فكرة تسخين اعواد التبغ الشبيهة بالسجائر.



وسائل ايصال النيكوتين الكترونياً (السيجارة الالكترونية، الشيشة الالكترونية وغيرها من المنتجات التي يستخدم فيها النيكوتين الكترونياً ويطلق عليها الفيب) Electronic Nicotine Delivery System (ENDS)

ظهرت هذه الوسائـل لاول مرة عام 2003 حيث قام الكيميائي الصيني هون ليك (Hon Lik) بتصنيعها والترويج لها في بادئ الامر على انها البديل المناسب للسجائر العادية، و في عام 2004 طرحت في الأسواق العالمية مصحوبة بدعاية كبيرة من قبل الشركات المنتجة على انها الحل الناجح للإقلاع عن التدخين ومنذ ذلك التاريخ انتشرت هذه الوسائل في العالم مثل النار في الهشيم، وأقبل عليها كثير من المدخنين وغير المدخنين، بعضهم لرغبة منه في تجربتها والبعض الاخر لمحاولة ترك التدخين ووجدوا لها سوقاً رائجاً عند الشباب وهنا نشطت المصانع في انتاج أشكال مختلفة ومبتكرة وجميلة لتروق لعدد أكبر من الناس وأصبحت تجارة رائجة تدر على الشركات أرباحاً طائلة.









تتكون هذه الوسائل (النُظُم) من بطارية يتم تنشيطها اثناء الاستنشاق وتعمل على تسخين حاوية صغيرة تحتوي على سائل يعرف بالسائل الالكتروني او العصير الالكتروني لإصدار رذاذ يستنشقه المستخدم، وغالباً ماتحتوي هذه السوائل الإلكترونية على النيكوتين (وليس التبغ)، حيث تُطلق بخارًا مصنوعًا من جزيئات دقيقة ومتناهية في الصغر من الجسيمات المعلقة، التي وُجد أنها تحتوي على البروبيلين جليكول، الجليسرين، النيكوتين، النكهات، عدد كبير من المواد السامة، المسرطنات، الفلزات الثقيلة، الجسيمات النانوية المعدنية، وغيرها من المواد التي تضر بصحة الانسان ومن اضرارها:

- التسمم جراء وجود المواد الكيميائية والمعادن الثقيلة فيها مثل الرصاص، الكروم، النيكل، النحاس، الالومنيوم والزئبق.
- تلف الرئتين مع زيادة احتمالية الاصابة بأمراض القلب ونوبات الربو القصبي.
- إدمان النيكوتين بشكل كبير جداً.
- صداع، دوار، تخدش الاغشية المخاطية للعينين والبلعوم مع سعال شديد.
- التسمم جراء تسرب مادة النيكوتين السائل الى الفم مع غثيان وتقيؤ شديدين.
- يؤثر سلباً في عملية بناء وتطور الدماغ لدى المراهقين ويقلل من مناعة الجسم.

- جذب الأطفال والمراهقين لعادة التدخين بسبب شكل السيجارة الالكترونية والشيشة الإلكترونية الجذاب ونكهاتهما المتعددة.
- الإغراء بمواصلة عادة التدخين خاصة لدى الشباب والمراهقين.
- انفجار البطارية مما يسبب حروق و اضرار صحية بالغة.



تم الاعلان عن اول حالة وفاة جراء استخدام السجائر الالكترونية في الولايات المتحدة الامريكية/ ولاية ألينوي اواخر شهر اب (اغسطس) عام 2019



أظهرت نتائج بعض الدراسات بأنّ التعرض للدخان المُنبعث من السجائر الإلكترونية، ولو بمعدلاتٍ مُتدنيّة كفيلٌ بأن يتسبّب بإحداث تغييرات ملحوظة في الرئتين، ما يؤدي لاحقًا إلى تلفهما، خصوصًا لدى استخدام السجائر على المدى البعيد، إذ إنّ استنشاق الهواء الذي يحمل رذاذاً من نواتج احتراق السائل الموجود داخل السيجارة الإلكترونية لمدة طويلة يتسبّب بتغييراتٍ في مكونات الخلايا المناعية الرئوية، إلى جانب قدرته على التسبُّب بتغييرات على المستوى الجيني والبروتيني في الرئتين مصحوباً بتجمع مايعرف بالسائل الزيتي داخل الحويصلات الهوائية مسبباً الاختناق.

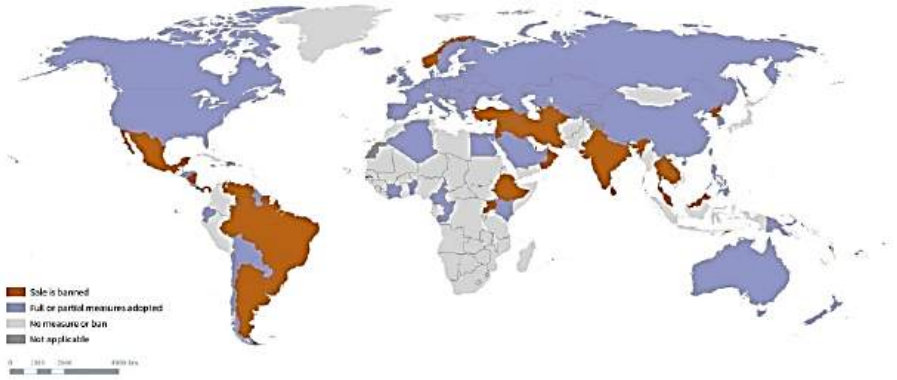
موقف العراق الرسمي تجاه وسائل ايصال النيكوتين الكترونياً (السجائر والشيشة الالكترونية – Vape)

اصدرت الهيئة الاستشارية لسلامة الاغذية القرارين رقم (170) لسنة 2011 و (231) لسنة 2020 والمتضمنين (منع استيراد وتداول وبيع وتصنيع السجائر الالكترونية والشيشة الالكترونية ومنع الاعلان عنها).

موقف دول العالم تجاه وسائل ايصال النيكوتين الكترونياً (السجائر والشيشة الالكترونية – Vape) لغاية عام 2022

تقوم 87 دولة في العالم باعتماد تشريعات وطنية (كلية او جزئية) لتنظيم وسائل ايصال النيكوتين الكترونياً بينما اصدرت 34 دولة (من بينها العراق) حظراً تاماً على بيعها وتداولها.

Fig. 47. Measures to regulate ENDS – full, partial or no ban, 2022



ENDS are regulated in: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Barbados, Belarus, Belgium, Benin, Bolivia (Plurinational State of), Bulgaria, Cameroon, Canada, Chile, China, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Estonia, Fiji, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guyana, Honduras, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, Latvia, Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Nepal, Netherlands (Kingdom of the), New Zealand, Niue, North Macedonia, Palau, Papua New Guinea, Paraguay, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Saint Lucia, Samoa, San Marino, Saudi Arabia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Tajikistan, Togo, Tuvalu, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, the United States, Uzbekistan

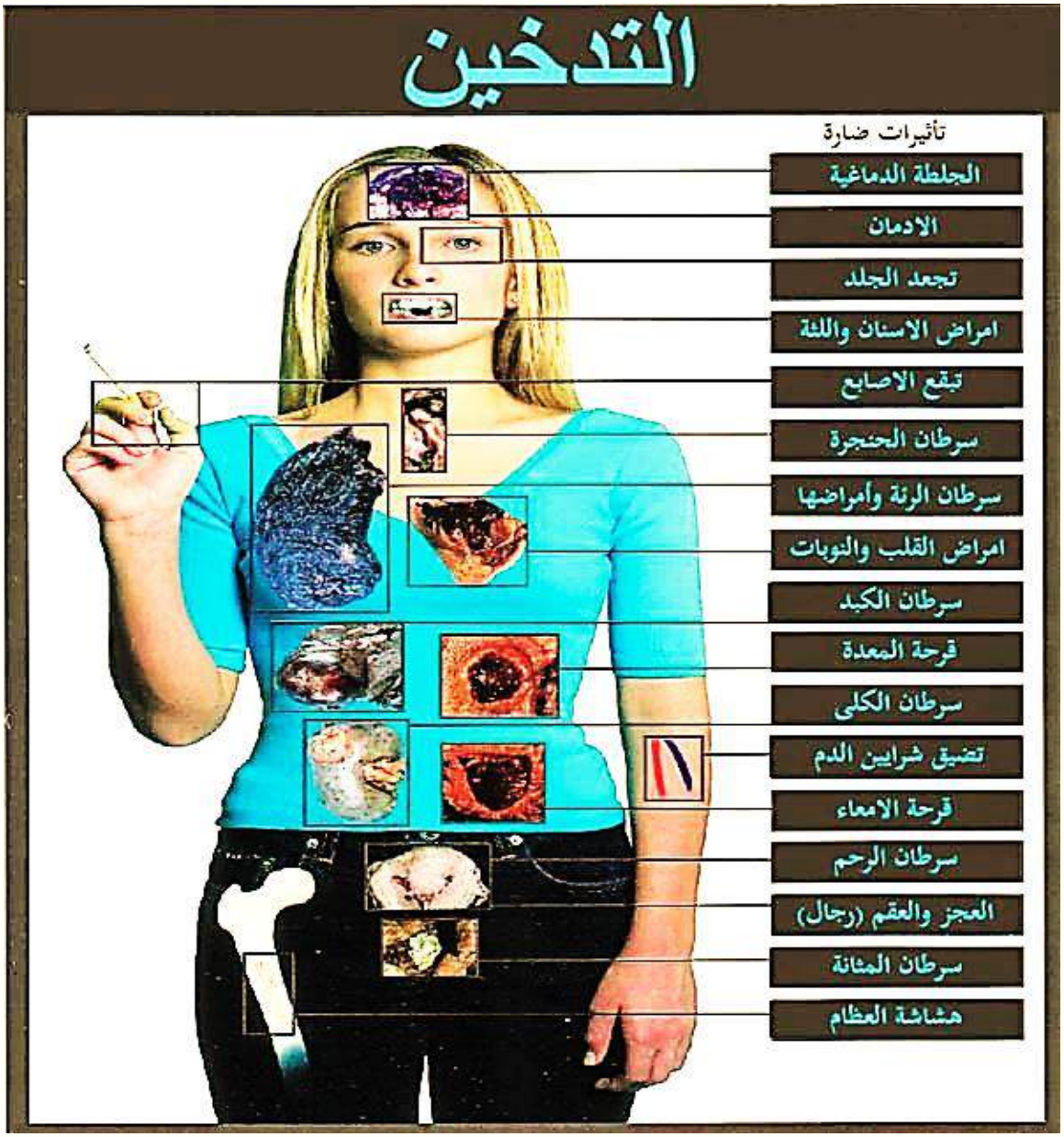
Sale of ENDS is banned in: Argentina, Brazil, Brunei Darussalam, Cabo Verde, Cambodia, Democratic People's Republic of Korea, Ethiopia, Gambia, India, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Jordan, Lao People's Democratic Republic, Malaysia, Mauritius, Mexico, Nicaragua, Norway, occupied Palestinian territory, Oman, Panama, Qatar, Singapore, Sri Lanka, Suriname, Syrian Arab Republic, Thailand, Timor-Leste, Türkiye, Turkmenistan, Uganda, Uruguay, Vanuatu, and Venezuela (Bolivarian Republic of).

تنتج السيجارة الالكترونية 127 مادة كيميائية شديدة السمية واكثر من 225 مادة مهيجة تساهم في تدمير الحامض النووي للانسان

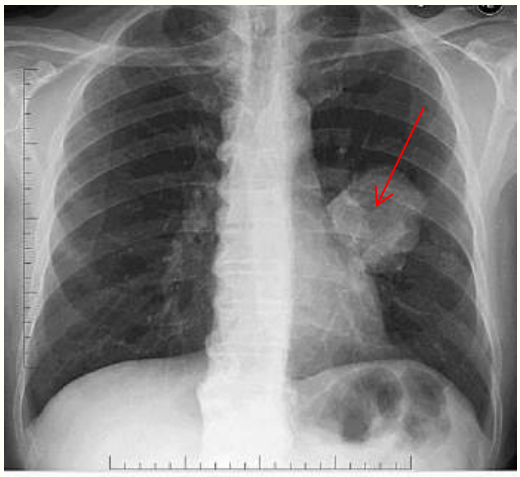
اضرار التبغ

الأضرار الصحية

يعتبر التدخين واحداً من اهم اسباب الوفيات المبكرة في العالم حيث يتسبب التبغ بطيف واسع من الأمراض والتاثيرات الصحية على جسم الانسان كامراض القلب والاوعية الدموية والرئتين والسرطانات (مثل سرطان الرئة والحنجرة والبنكرياس وغيرها) وهو عامل خطر كبير للنوبات القلبية والجلطات والسكتات الدماغية والانسداد الرئوي المزمن COPD بالاضافة الى تسببه بضرر كبير في الاوعية الدموية الطرفية.

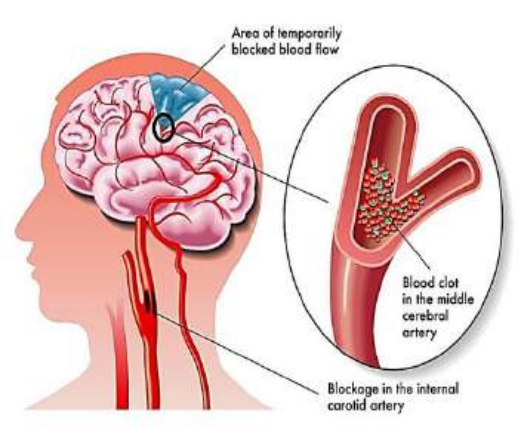


التبغ وسرطان الرئة



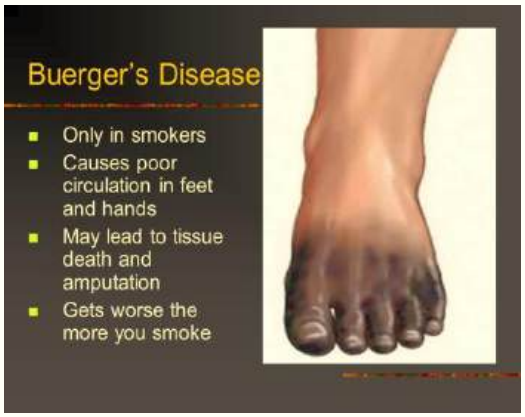
يُعَدُّ تدخين التبغ السبب الرئيسي لسرطان الرئة، وهو المسؤول عن أكثر من ثلثي وفيات سرطان الرئة على مستوى العالم كما أن التعرّض لدخان التبغ غير المباشر في المنزل أو في مكان العمل يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة حيث تدخل المواد الكيميائية والمسرطنة الناجمة عن انبعاثات احتراق التبغ إلى الرئتين مسببةً تلف الحامض النووي داخل الخلايا التي تبطن الشعب الهوائية حيث يحاول الجسم إصلاح هذا الضرر ولكن في النهاية، يصبح غير قادر على ذلك، فتتشكل الخلايا السرطانية.

التبغ والسكتة الدماغية



تزداد نسبة الاصابة بالسكتة الدماغية لدى المدخنين باربعة اضعاف مقارنةً بغير المدخنين، كما تزداد نسبة حدوثها لدى غير المدخنين ممن يتعرضون للتدخين السلبي في اماكن العمل او الاماكن المغلقة الاخرى، كما وتقل نسبة الاصابة بالسكتة الدماغية لدى المدخنين الذين اقلعوا عن التدخين مبكراً، وقد اثبتت البحوث والدراسات العلاقة بين السكتة الدماغية وتعاطي التبغ غير المُدخَّن.

التبغ ومرض ساق المدخن (Buerger)



يؤدي استخدام التبغ الى حدوث ضرر كبير في بطانة الاوعية الدموية للساقين Peripheral artery disease مسببةً انتفاخاً وآلاماً شديدة نتيجة ضعف تدفق الدم فيهما، حيث يشعر المدخن بتلك الالام في بادئ الامر عند السير لمسافة تزيد عن 200 متر ومع تقدم المرض يبدأ المدخن بالشعور بتلك الالام حتى اثناء الراحة والسكون حيث تنشأ التقرحات والالتهابات كعلامة على موت الانسجة (Gangrene) التي تنتهي إلى بتر الجزء المصاب من الجسم.

التبغ وسرطان الثدي



اثبتت الدراسات والبحوث العلمية ان المراة المدخنة اكثر عرضة من غيرها للاصابة بسرطان الثدي وان نسبة الاصابة تزداد بشكل كبير جداً اذا بدأت المراة بالتدخين في سن مبكرة وعادةً ما يكون من النوع الشرس الذي لايستجيب للعلاج Hormone Receptor Negative ويزيد التدخين من مخاطر العلاج الاشعاعي والهورموني ويؤخر الشفاء من العلاج الجراحي وان الاقلاع المبكر عن التدخين يقلل من نسبة الاصابة بهذا المرض، وقد لوحظ ان التعرض للتدخين السلبي يساهم في حدوث المرض لذا فأن زوجات المدخنين اكثر عرضة من غيرهن للاصابة بسرطان الثدي.

التبغ وامراض القلب والاوعية الدموية



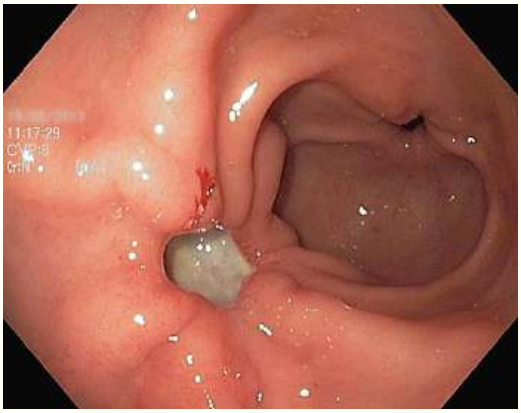
يؤدي تعاطي التبغ الى موت 1.9 مليون شخص سنوياً جراء اصابتهم بمرض القلب التاجي، أي مايعادل خُمس مجموع الوفيات الناجمة عن الأمراض القلبية، حيث يسبب التدخين ضرر كبير بجدران الاوعية الدموية فيسهل تراكم الصفائح والتي تنتهي بانسداد الشرايين كما يلعب دور كبير في انخفاض مستويات الاوكسجين في الدم مما يضاعف من جهد عضلة القلب في تزويد الجسم بالاوكسجين الذي يحتاجه ويقلل من تدفق الدم الى اعضاء الجسم الاخرى فيحدث تصلب في جدران الاوعية الدموية كما وانه يرفع من مستوى ضغط الدم ويزيد من معدلات نبض القلب.

يتعرض المدخنين الى الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية في سن أصغر مقارنة بغير المدخنين.

ومن الجدير بالذكر فأن التبغ غير المدخَّن مسؤول هو الاخر عن حوالي 200 ألف حالة وفاة سنوياً ناجمــة عن مرض القلب التاجـــــي كمـا تتسبب السجائر الإلكترونية في ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية.

التبغ وامراض المعدة والامعاء

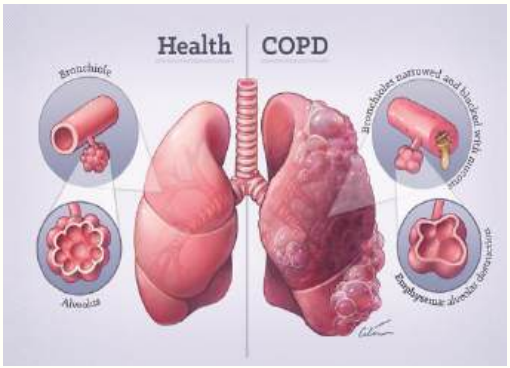
يتأثر المدخنون اكثر من غيرهم بدخان التبغ الذي يتم استنشاقه او بلعه مما يساهم بحدوث حرقة المعدة بسبب ارتجاع الحامض المعدي الى الجزء السفلي من المريء فيحدث ضررا كبيرا في البطانة الداخلية كما يصيب بطانة المعدة التي تنتهي بالقرحة في اغلب الاحيان وما يفاقم الحالة ويعرقل من شفاؤها هو استمرار المدخن بالتدخين وما يرافق ذلك من زيادة احتمالية الاصابة بجرثومة المعدة وعادة ما يحدث فقدان في الشهية ونقص في الوزن ومن الجدير بالذكر فان التدخين يزيد من احتمالية الاصابة بمرض كرون crohn's disease ومـا يـرافقـه مـن الام والتهابات البطانة الداخلية



للامعاء الدقيقة، وكذلك يزيد من احتمالية تشّكل حصى المرارة خاصة لدى النساء المدخنات.

التبغ والامراض الانسدادية التنفسية المزمنة (COPD)

يتسبب تعاطي التبغ بانسداد في القصبات الهوائية للجهاز التنفسي ويتفاقم هذا الانسداد تدريجياً مما يؤدي الى قصور في وظائف الرئتين وتلفهما ويصبح غير قابل للعلاج حتى ينتهي بالوفاة، ويعتبر التدخين السبب الاساسي في حدوث هذا المرض حيث يصيب مابين 10-20% ممن تجاوزت اعمارهم 40 عاماً ويتسبب بوفاة (2.5) مليون شخص سنوياً والطريقة الوحيدة لتجنب حدوث المرض هي في عدم التدخين او في الاقلاع عنه، وبالاضافة الى ذلك فان من المهم جداً تجنب الامـاكن المغلـقة التى يدخن بها الاخـرون حيث



يساهم الدخان غير المباشر (التدخين السلبي) في مزيد من التلف الحاصل في الرئتين.

التبغ ومشاكل الجلد والبشرة

يقلل التدخين من تدفق الدم الى الجلد مما يحرم البشرة من الأوكسجين والمواد المغذية الاخرى، فيجعله يبدو شاحباً متعباً ومتجعداً مع ظهور بقع صبغية على الوجه وظهر الكفين مع زيادة احتمالية الاصابة بداء الصدفية.

يتـأثر الكولاجين الموجود في طبقـات الجلـد بـالتـدخين ممـا يســـاهم في حـدوث الترهلات والتجاعيد المبكرة.



التبغ وامراض العيون

يُعد التدخين أحد أسباب الإصابة بتضيق الشرايين، وخاصة شرايين شبكية العين، مما يؤدي الى ضعف تدفق الدم نحو الخلايا البصرية وبالتالي إضعاف البصر أو فقدانه بالكامل، كما يزيد التدخين من ضغط العين مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمرض الجلوكوما، والذي يؤثر على الإبصار مع تقدم الشخص في العمر.

لا شك أن معظم الأشخاص سواءً كانوا مدخنين أم غير مدخنين قد لاحظوا آثار ملامسة الدخان للعين بشكل مباشر، حيث أنها تؤثر على الغشاء الخارجي الحساس للعين وتتسبب في تهيجه والتهابه واحمراره.

يتعرض المدخنون اكثر من غيرهم لخطر الاصابة بالماء الابيض (الساد) حيث تشير الدراسات الى ان المدخنين عرضة للاصابة بهذا المرض بمعـــــدل



خمسة اضعاف مقارنة بغير المدخنين.

ومن الجدير بالذكر فان للتدخين مخاطر اخرى على صحة العين لاتقل اهمية عن ما تم ذكره كالتهاب القزحية واعتلال الشبكية السكري (لدى مرضى السكري) والمتمثل بحصول نزيف داخل الشبكية والذي غالباً ما ينتهي بالعمى.

التبغ والضعف الجنسي



بالرغم من الصورة المغايرة للحقيقة التي يراها البعض في ان التدخين يمثل مظهراً من مظاهر الرجولة، تشير معظم الدراسات الى ان التدخين يؤثر على صحة الرجل الانجابية وقدرته الجنسية فهو يزيد من مخاطر الاصابة بالعقم ويسبب ضعف الانتصاب وذلك بسبب نقص وصول الدم الى الجهاز التناسلي الذكري كما يرتبط التدخين بحدوث بعض المشاكل الصحية في طبيعة وشكل الحيوانات المنوية.

ومن الجدير بالذكر فان التوقف عن التدخين سيساهم في اعادة القدرة الجنسية للرجل من خلال التحسن الذي سيطرأ على الدورة الدموية.

التبغ وصحة الحامل والجنين

تدخين المراة الحامل يزيد من نسبة أول أوكسيد الكربون في الدم وهذا يعني انخفاض كمية الأوكسجين الذاهبة للجنين عن طريق الحبل السري، مما يزيد من سرعة نبض قلب الجنين وزيادة الإجهاد الكلي على جسمه الذي ما زال في طور النمو، كما تزداد نسبة حدوث الحمل خارج الرحم لدى النساء المدخنات بأربعة أضعاف حدوثها لدى النساء غير المدخنات.

يزيد التدخين لدى النساء الحوامل من خطر الاصابة بالولادات المبكرة والاسقاط ونقص وزن الجنين بمقدار 200-250 غرام عن المعدل الطبيعي. كما ان التدخين خلال الحمل يزيــد من



معدلات موت الطفل لدى ولادته أو بعد ذلك بفترة قصيرة (متلازمة موت الرضيع المفاجئ). Sudden Infant Death Syndrome (SIDS)

التبغ وصحة الرضيع

يصاب الطفل الرضيع الذي يتعرض لدخان التبغ بالتهابات الجهاز التنفسي المتكررة مع احتمالية حدوث نوبات من الربو ، بالاضافة الى ذلك يؤدي التعرض لمستويات عالية من غاز اول اوكسيد الكاربون المنبعث من التبغ المحترق والناتج عن التدخين السلبي الى تفاقم الحساسية مع زيادة خطر الاصابة بالتهابات الاذن مع ضعف في وظيفة الشم بالاضافة الى العديد من امراض الجهاز التنفسي الاخرى.

تشير الدراسات الى ان كل عشرين سيجارة تدخنها الام المرضع تؤدي الى افراز مامقداره (5) ملغم من النيكوتين في كل لتر واحد من حليبها مما يقلل من تدفـق الحليب الى الطفـــل الرضيــع فتضطــر



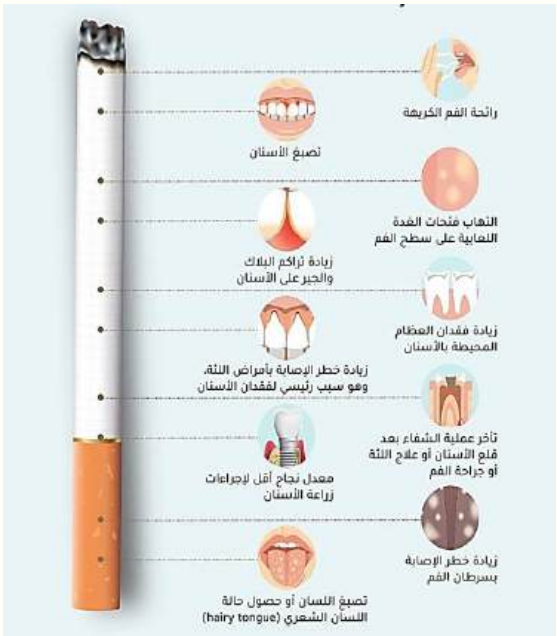
المرأة المدخنة الى فطام طفلها قبل الاوان. كما يتوقع أن يكون أطفال الأمهات اللواتي دخّن خلال فترة الحمل أقصر طولا من الأطفال الآخرين.

التبغ وصحة الفم والاسنان

بما أن دخان السيجارة يمر عبر الشفتين والفم فإن مختلف المواد السامة المنبعثة مع الدخان ستؤثر بطريقة أو بأخرى على سلامة الفم والأسنان ومن بين تلك التاثيرات ماياتي:

- تدمير أنسجة وخلايا اللثة ومنعها من أداء وظائفها الطبيعية.
- التأثير على البكتيريا النافعة المتواجدة في الفم والتي لها دور كبير في منع الإصابة بمختلف أمراض الفم والأسنان.
- إبطاء عملية شفاء أي جرح داخل الفم واللثة، بسبب قلة تدفق الدم إلى انسجة الفم.
- زيادة معدل الإصابة بجير الأسنان، الذي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالعديد من مشكلات اللثة والأسنان.
- جفاف الفم بسبب قلة إفراز اللعاب.
- ضعف في حاسة التذوق والشم
- تسوس الاسنان بسبب الضرر الذي يحدثه التدخين على انسجة اللثة وترك جذور الاسنان مكشوفة.
- انبعاث الروائح الكريهة من الفم
- تصبغ واصفرار الاسنان
- سرطان الفم واللسان والشفتين حيث تزداد نسبة الاصابة بهذه السرطانات بمعدل 6 اضعاف مقارنة بالاشخاص غير المدخنين.

ولاتختلف هذه الاضرار باختلاف نوع التبغ المستخدم حيث يتسبب التبغ غير المدخن وكذلك السجائر الالكترونية بنفس الاضرار التي سبق ذكرها.





مرض التبغ الاخضر

لاتتوقف اضرار التبغ عند حد معين بل تتعدى ذلك بكثير حيث يؤثر التبغ على صحة المزارعين الذين يقومون بزراعته وحصاده من خلال امتصاص كمية من النيكوتين عن طريق الجلد يومياً تعادل نفس القدر من النيكوتين الموجود في 50 سيجارة وهو ما يسمى بمرض التبغ الأخضر Green Tobacco Sickness (GTS) وهو شكل من أشكال التسمم بالنيكوتين الذي يحدث في 1 من بين كل 4 مزارعين، وتتفاقم هذه الحالة عند الاطفال الذين يعملون مع أسَرِهم في هذه الحقول بسبب قلة اوزانهم قياساً الى كمية النيكوتين التي تمتصها جلودهم اثناء ملامستهم لاوراق التبغ، بالاضافة الى ذلك قد يعاني مزارعو التبغ أيضا من زيادة تركيز الألومنيوم والزرنيخ في الدم بسبب التعرض للمبيدات الزراعية حيث يؤدي التعرض المزمن لبعض المبيدات الحشرية إلى العديد من الآثار الصحية بما في ذلك العيوب الخلقية والأورام الحميدة والخبيثة والتغيرات الجينية واضطرابات الدم والاضطرابات العصبية واضطراب الغدد الصماء.



التدخين السلبي

الاستنشاق غير الإرادي للدخان الناتج عن تدخين (احتراق) منتجات التبغ ويسمى ايضاً بالتدخين القسري أو التدخين بالإكراه ويتسبب باضرار جسيمة للاشخاص الذين يجالسون المدخن وخاصة الاطفال.

عالمياً يتسبب التدخين السلبي بوفاة 1300000 (مليون وثلاثمائة الف) شخص سنوياً من غير المدخنين (بسبب تعرضهم لدخان التبغ في الاماكن العامة المغلقة)، الالاف منهم من الاطفال، اما في مواقع العمل فيتسبب التدخين السلبي بوفاة حوالي 300000 (ثلاثمائة الف) شخص.

في العراق تشير اخر الاحصائيات المستندة الى نتائج المسح العالمي للشباب حول استخدام التبغ للفئة العمرية (13 – 15) سنة والذي شمل طلاب المدارس المتوسطة لعام 2019 الى ان حوالي 44.8% منهم يتعرضون للتدخين السلبي في منازلهم، و 43.4 % يتعرضون لخطر التدخين السلبي في الاماكن العامة المغلقة.



الأضرار البيئية

فقدت الأرض ما يقدر بنحو 1.5 مليار هكتار من الغابات في جميع أنحاء العالم منذ عام 1970 بسبب التبغ، مما ساهم في ما يصل إلى 20% من الزيادة السنوية في الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، حيث يتم تطهير اكثر من 200000 هكتار من الأراضي سنويا لزراعة التبغ على حساب المحاصيل الزراعية الاساسية الاخرى مما يؤثر سلباً على الامن الغذائي العالمي ويساهم في حدوث المجاعة.

يتم قطع 600 مليون شجرة سنوياً لصناعة السجائر حيث يستفاد من الشجرة الواحدة في تصنيع 300 سيجارة فقط.

التبغ يلوث الهواء



لإنتاج سيجارة واحدة (زراعة، تصنيع واستخدام)، ينبعث 14 غرام من غاز ثاني اوكسيد الكاربون CO_2 الى الجو حيث يساهم إنتاج التبغ بانبعاث ما يقرب من 84 مليون طن من CO_2 سنويا وهذا يعادل الغاز المتولد من إطلاق 280 ألف صاروخ إلى الفضاء الخارجي.

يساهم دخان التبغ في ارتفاع مستويات تلوث الهواء حيث يطلق المدخن الواحد ما يقارب من (5) أطنان من غاز ثاني أوكسيد الكاربون الى الغلاف الجوي

التبغ يلوث المياه



تتطلب دورة الحياة الكاملة لسيجارة واحدة حوالي 3.7 لتر من الماء، وهذا يشمل الزراعة والتصنيع والتوزيع والاستخدام والتخلص منها بعد الاستخدام (القمامة). ويمكن للمدخن العادي توفير ما يصل إلى 74 لترا من الماء يوميا إذا أقلع عن التدخين، وبالنظر الى ان الشخص الواحد يشرب حوالي 700 لتر من الماء سنوياً فسيكون بامكان تارك التدخين تروية مايقارب من 40 شخص حول العالم.

زراعة التبغ تستنفذ منسوب المياه على كوكب الارض.

التبغ يلوث التربة

تستخدم الأراضي الخصبة في زراعة التبغ بدلاً من استخدامها في زراعة المحاصيل الغذائية ويساهم ذلك في شحة المحاصيل الزراعية الأساسية، حيث ان إعادة تأهيل التربة بعد زراعة التبغ تكون مكلفة جدا.

من الثابت أن مرشحات السجائر (الفلتر) هي من بين أعلى المواد الملوثة والسامة الموجودة في التربة، حيث يستغرق عقب السيجارة حوالي 10 سنوات ليتحلل، مما يتيح الوقت الكافي للنيكوتين والمواد الكيميائية الأخرى للتسرب إلى أعماق التربة والمياه المحيطة.

على الصعيد العالمي، يبلغ الوزن التقريبي للنفايات المتولدة سنويا من دورة حياة التبغ الإجمالية حوالي 680 مليون طن مما يرهق كاهل الدول في تخصيص مبالغ ضخمة للتخلص منها بطريقة صحية وامنة.

يرمي المدخنون حوالي 4.5 تريليون سيجارة في البيئة كل عام حيث وجدت الدراسات الاستقصائية لسلوك القمامة أن ما يقرب من 65% من المدخنين يتخلصون من أعقاب السجائر بشكل غير صحيح (على سبيل المثال، على الأرصفة والشواطئ وما إلى ذلك) مما يساهم في تراكم مخلفات السجائر وزيادة في معدلات التلوث.







الاضرار الاقتصادية

لا تقل اضرار التبغ الاقتصادية خطورة عن الاضرار الصحية او البيئية على الفرد والمجتمع حيث تشير احدى الدراسات العالمية التي أجراها المعهد الوطني الأمريكي للصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية إلى أن التدخين يكلف الاقتصاد العالمي سنويا ما يفوق تريليون دولار مما يساهم في زيادة معدلات الفقر وخاصة في الدول النامية، ويمكن ادراج اهم التاثيرات الاقتصادية للتبغ فيما يأتي:

- تكاليف الرعاية الصحية: بما ان التدخين هو أحد العوامل الرئيسية التي تسبب الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي كما ورد انفاً لذا فهو يشكل عبئاً كبيرا على ميزانية الدولة جراء النفقات الطائلة التي تخصصها لخدمات الرعاية الصحية المتعلقة بعلاج هذه الأمراض.
- ضعف الانتاج: يؤثر التدخين على قدرات الافراد الإنتاجية حيث يعاني المدخنون من مستويات أقل من الطاقة واللياقة البدنية، مما يؤثر سلبًا على أدائهم في العمل وقدراتهم على تحقيق إنتاجية عالية، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يتسبب التدخين في زيادة الغيابات عن العمل بسبب المرض والإصابات المترتبة عليه كما انه يزيد من معدل الوفيات المبكرة والعوق مما يقلل من الموارد البشرية المتاحة للعمل والتنمية.
- التكاليف الاجتماعية: يترتب على التدخين تكاليف اجتماعية عالية، كالمبالغ التي تخصصها الحكومات للتوعية والتثقيف بمخاطر التبغ وتقديم برامج إقلاع عن التدخين كما تتضمن التكاليف الاجتماعية أيضًا تكاليف الحوادث المرتبطة بالتدخين، مثل حرائق السجائر والحوادث المرورية.
- مدخولات الأُسرة: تشير الدراسات الى ان التدخين يزداد في المجتمعات الفقيرة والمتوسطة الدخل مما يؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي للأُسرة حيث ينفق المدخنون مبالغ طائلة سنوياً على شراء منتجات التبغ اضافة الى ما ينفق بشكل شخصي- على علاج الامراض المترتبة على تعاطي التبغ والحفاظ على الصحة وكل ذلك على حساب مصروف المدخن ومصروف اسرته.

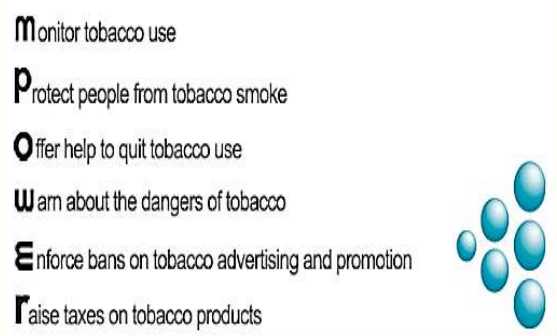
في العراق يبلغ مجموع ماينفقه المدخنون على شراء منتجات التبغ (السجائر وغيرها) اكثر من (3) ثلاثة مليارات دينار عراقي يومياً بحسب البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط لعام 2021 ومن الجدير بالذكر فان 2.3% من الدخل السنوي للفرد العراقي ينفق على شراء السجائر بحسب المسح الوطني لعوامل خطورة الامراض غير الانتقالية لعام 2015 .

التزامات العراق الدولية



صادق العراق على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة التبغ
Framework convention on tobacco control (FCTC)
عام 2007 حيث تهدف هذه الاتفاقية الى حماية الاجيال الحالية والمقبلة من العواقب الصحية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية المدمرة الناجمة عن تعاطي التبغ والتعرض لدخانه

اطلقت منظمة الصحة العالمية استراتيجية الـ (MPOWER) المنبثقة عن الاتفاقية الاطارية بشأن مكافحة التبغ عام 2008 لمساعدة البلدان الاطراف في الاتفاقية على وضع الخطط اللازمة لمكافحة التبغ على المستوى الوطني وتتألف من السياسات الست التالية



- رصد معدلات تعاطي التبغ
- الحماية من التعرض لدخان التبغ
- تقديم خدمات المساعدة للمدخنين الراغبين بالاقلاع عن التدخين
- التحذير من اخطار التبغ
- حظر الاعلان والدعاية والترويج لمنتجات التبغ ورعايتها
- زيادة الضرائب المفروضة على منتجات التبغ



صادق العراق على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ عام 2015 بهدف القضاء على جميع اشكال التجارة غير المشروعة بمنتجات التبغ وفقاً لاحكام المادة (15) من الاتفاقية الاطارية بشأن مكافحة التبغ من خلال انشاء نظام صارم لتتبع وتعقب منتجات التبغ ابتداءً من بلد المنشأ وانتهاءً بالبلد المستورد.

التزامات العراق الوطنية



صدر قانون مكافحة التدخين في العراق رقم (19) بتاريخ 2012/2/2 وتم اعتبار ذلك اليوم يوماً وطنياً للامتناع عن التدخين يتم الاحتفال به سنوياً حيث يهدف القانون الى حماية الاشخاص من اخطار التدخين الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وتقليل نسبة المدخنين من خلال وضع معايير لمكافحة التدخين

قرارات الهيئة الاستشارية لسلامة الاغذية

- ✓ قرار رقم (170) لسنة 2011 والمتضمن منع استيراد وتداول السجائر الالكترونية
- ✓ قرار رقم (231) لسنة 2020 والمتضمن توسيع منع استيراد وتداول السجائر الالكترونية ليشمل (منع البيع والتصنيع والاعلان عن وسائل ايصال النيكوتين الكترونياً - السيجارة الالكترونية والشيشة الالكترونية -)
- ✓ قرار رقم (233) لسنة 2021 والمتضمن عدم السماح باستيراد منتج التبغ المسخن للاسباب التالية:

- ان العراق من الدول المنضوية تحت اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة التبغ التي نصت على منع البدء بانتاج تبغ جديد وناشئ.
- لاتساعد المدخنين على الاقلاع عن تعاطي التبغ.
- لاتوجد حالياً بيّنات تدل على ان منتجات التبغ المسخن اقل ضرراً من منتجات التبغ التقليدية.
- تصدر عنها انبعاثات سامة مماثلة لتلك الصادرة عن دخان السجائر والتي يمكن للعديد منها ان تسبب السرطان.
- بالرغم من احتواء التبغ المسخن على نسب اقل لبعض المواد السامة الموجودة في السجائر التقليدية الا انه يوجد مواد سامة اضافية غير موجودة في السجائر التقليدية بامكانها ان تلحق الضرر بصحة الانسان.

مكافحة التبغ في الرعاية الصحية الاولية

➢ على مستوى دائرة الصحة:

تقوم وحدة مكافحة التبغ التابعة لشعبة الامراض غير الانتقالية في دائرة الصحة بمهام وواجبات مكافحة التبغ على مستوى الدائرة وكما يأتي:

- ✓ تشكيل لجنة مكافحة التبغ في الدائرة لتسهيل تنفيذ الخطة على مستوى المحافظة.
- ✓ تدريب مسؤولي مكافحة التبغ والصحة المدرسية وتعزيز الصحة والرقابة الصحية في القطاع على الاليات التنفيذية للخطة ووسائل المتابعة.
- ✓ العمل على ادراج خدمات التحرر من التبغ في مراكز الرعاية الصحية الاولية الرئيسية والتدريب على اليات تنفيذها وبضمنها التدريب على خدمات الاقلاع عن التدخين.
- ✓ تدريب الملاكات الصحية والتربوية على اليات عمل مشروع مدارس مناهضة للتدخين بالتنسيق مع الصحة المدرسية ومديرية التربية في المحافظة وبحضور مدراء المراكز الصحية ضمن الرقعة الجغرافية للمدارس المشمولة بالمشروع.
- ✓ القيام بحملة وطنية شاملة لمناهضة التدخين لمدة ثلاثة اسابيع متتالية (على الأقل) لنشر الوعي الصحي باضرار التبغ والحث على اجتنابه.
- ✓ اقامة الندوات وعقد المحاضرات التوعوية حول اضرار التبغ في المؤسسات الصحية وخارجها.
- ✓ القيام بزيارات ميدانية لمراكز الرعاية الصحية الاولية الرئيسية للاشراف على تنفيذ الخطة في تلك المراكز.
- ✓ التنسيق مع مكتب المحافظ ومجلس المحافظة والنقابات الطبية والصحية للمساهمة في تنفيذ الخطة.
- ✓ التنسيق مع مديرية المرور والاتحادات الرياضية والجامعات والكليات الحكومية والاهلية والمؤسسات والدوائر البلدية وهيئة الاعمار والاسكان في المحافظة للمساهمة في تنفيذ الخطة.

➢ على مستوى القطاع:

يقوم مسؤول مكافحة التبغ في القطاع بمهام تنفيذ خطة مكافحة التبغ على مستوى القطاع ومتابعة تنفيذها في مراكز الرعاية الصحية الاولية الرئيسية التابعة له وكما يأتي:

- ✓ المتابعة الميدانية لتنفيذ مفردات خطة مكافحة التبغ في مراكز الرعاية الصحية الاولية بالتنسيق مع مسؤولي الصحة المدرسية وتعزيز الصحة والرقابة الصحية ومدراء المراكز وتتضمن ما يأتي:
  - منع التدخين داخل المركز الصحي بصورة مطلقة مع وجود دلالة منع التدخين في مدخل المركز.

- منع ادخال علب السجائر للمراجعين.
- وجود مواد توعوية (بوسترات, فلكسات، فولدرات... الخ) في اروقة المركز وعلى الجدران اضافة الى عرض المشاهد والمقاطع التثقيفية في شاشات العرض الموجودة داخل المركز.
- منع بيع منتجات التبغ في حدود المركز الصحي وداخله.
- متابعة تنفيذ الندوات والمحاضرات التوعوية عن اضرار التبغ من قبل مسؤولي مكافحة التبغ وتعزيز الصحة في المركز الصحي (بمعدل محاضرة واحدة داخل المركز الصحي فصلياً واخرى خارج المركز الصحي ضمن الندوات التوعوية فصلياً).
- المساهمة بتنظيم احتفاليات اليوم الوطني واليوم العالمي للامتناع عن التدخين.
- متابعة قيام وحدة الصحة المدرسية في المركز الصحي بالزيارات الميدانية الى المدارس المشمولة بمشروع مدارس مناهضة للتدخين ضمن الرقعة الجغرافية للمركز وفقاً لاستمارة المتابعة الميدانية المعدّة لهذا الغرض.

✓ تدريب الملاكات الطبية والصحية والادارية في مراكز الرعاية الصحية الاولية الرئيسية (موقعيا) على اليات تقديم خدمات الحماية من اضرار التبغ (3A) وآليات تقديم خدمات الاقلاع عن التدخين (2A).

➢ على مستوى المركز الصحي:

✓ مدير المركز الصحي: يتولى متابعة تنفيذ خطة مكافحة التبغ داخل المركز الصحي واصدار الاوامر والتوجيهات اللازمة لتطبيق ضوابط منع التدخين داخل المؤسسة الصحية والمتضمنة ما يأتي:

- منع التدخين داخل المركز بصورة مطلقة مع وجود دلالة منع التدخين في مدخل المركز.
- منع ادخال علب السجائر للمراجعين.
- منع بيع منتجات التبغ في حدود المركز الصحي وداخله.
- وجود مواد توعوية (بوسترات,فلكسات، فولدرات... الخ) في اروقة المركز وعلى الجدران اضافة الى عرض المشاهد والمقاطع التوعوية حول اضرار التبغ على شاشات العرض الموجودة داخل المركز.
- متابعة تنفيذ الندوات والمحاضرات التوعوية حول اضرار التبغ.
- حضور الدورات التي تعقدها الدائرة او القطاع والخاصة بالتدريب على اليات تنفيذ خدمات الحماية من اضرار التبغ ومشروع مدارس مناهضة للتدخين (في حالة شمول مدرسة أو اكثر بالمشروع ضمن الرقعة الجغرافية للمركز الصحي).

ويتم متابعة التزام المركز الصحي بما ورد انفاً من خلال الزيارات الميدانية التي تقوم بها الوزارة او الدائرة او القطاع الى المركز الصحي وفقاً لاستمارة الزيارات الاشرافية المُعدّة لهذا الغرض (مرفق رقم -1-).

- ✓ وحدة الصحة المدرسية في المركز الصحي: تقوم الوحدة بمتابعة المدارس المشمولة بمشروع **المدارس المناهضة للتدخين** ضمن الرقعة الجغرافية للمركز الصحي من خلال الزيارات الميدانية لتلك المدارس بما لايقل عن زيارة واحدة في كل فصل دراسي (زيارتين سنوياً) باستخدام استمارة المتابعة الميدانية المُعدّة لهذا الغرض (مرفق رقم -2-)
- ✓ وحدة تعزيز الصحة في المركز الصحي: ادراج محاضرات توعوية عن اضرار التبغ وسبل الوقاية منه ضمن جدول المحاضرات الخاص بوحدة تعزيز الصحة في المركز الصحي بمعدل محاضرتين (على الاقل) داخل المركز الصحي فصلياً واخرى خارج المركز الصحي ضمن الندوات والمحاضرات التوعوية فصلياً بالتعاون مع مسؤول مكافحة التبغ في المركز الصحي.

مرفق رقم -1-

استمارة الزيارات الاشرافية لمراكز الرعاية الصحية الأولية الرئيسية

الدائرة:
اسم القطاع:
اسم المركز الصحي:
اسم مدير المركز الصحي:
الكثافة السكانية:
عدد المدارس المشمولة بمشروع مدارس مناهضة للتدخين المغطاة من قبل المركز الصحي:
تاريخ الزيارة:

ت	النشاط او الفعالية	المعيار	المقياس ٠	١	٢	الملاحظات ٠=غيرمنفذ,١= منفذ جزئي,٢= منفذ كامل
١	الحماية من التعرض لدخان التبغ	منع ادخال علب السكائر				
		وجود دلالة منع التدخين في مدخل المركز				
		منع التدخين داخل المركز بصورة مطلقة				
		منع بيع منتجات التبغ في حدود المركز الصحي وداخله				
		وجود كراس قانون مكافحة التدخين				
٢	ادخال خدمات التحرر من التبغ ضمن الرعاية الصحية الاولية (المداخلات المبسّطة للتحرر من التبغ 3A)	وجود كراس دليل مكافحة التبغ في الرعاية الصحية الاولية				
		هل يتضمن سجل التذاكر حقل عن حالة التدخين				
		وجود مخطط توضيحي عن خدمات الـــ 3A داخل المركز الصحي				
		تدريب الملاكات الطبية والصحية والادارية على تقديم الخدمة وفقاً للدليل				
٣	مدارس مناهضة للتدخين (في حالة وجود مدارس مشمولة بالمشروع ضمن الرقعة الجغرافية للمركز الصحي)	وجود كراس دليل مكافحة التبغ في المؤسسات التربوية				
		التدريب على اليات متابعة المشروع				
		القيام بزيارات ميدانية للمدارس المشمولة ضمن الرقعة الجغرافية				بمعدل زيارة واحدة في الفصل الدراسي الأول وأخرى في الفصل الدراسي الثاني.
٤	التوعية باضرار التبغ	القاء محاضرات توعوية عن التدخين داخل المركز بمعدل محاضرتين فصلياً (على الاقل)				على ان لا يقل عدد المشاركين في المحاضرة او الندوة عن (٢٠) مشارك توثق بامر اداري
		القاء محاضرة او ندوة توعوية عن التدخين خارج المركز (واحدة فصلياً على الاقل)				
		يتم عرض رسائل صحية عن التدخين للمراجعين في شاشات العرض				
		وجود سجل توثيق نشاطات وفعاليات المركز الصحي في مجال مكافحة التبغ				
		وجود مواد توعية (بوسترات, فولدرات) في أروقة المركز				

ملاحظة:
يتم احتساب درجة التقييم النهائية وفقاً لما يأتي:
١. درجة التقييم النهائية =(مجموع الدرجات×١٠٠)÷٣٤= (---%) في حالة وجود مدارس مشمولة بالمشروع ضمن الرقعة الجغرافية للمركز الصحي.
٢. درجة التقييم النهائية =(مجموع الدرجات×١٠٠)÷٢٨= (---%) في حالة عدم وجود مدارس مشمولة بالمشروع ضمن الرقعة الجغرافية للمركز الصحي.

مجموع الدرجات	درجة التقييم النهائية

مرفق رقم -2-

دائرة صحة.....

مديرية تربية .....
اسم المدرسة: .....
عدد التلاميذ: .....
العدد الكلي للكادر التدريسي.....
عدد الكادر التدريسي المدرب على المشروع.....

استمارة المتابعة الميدانية
لمشروع مدارس مناهضة للتدخين

شهر .....

- وجود فلكس كبير على باب المدرسة يشير إلى البدء بتنفيذ المشروع : نعم ☐ لا ☐
- وجود بوسترات مكافحة التدخين على جدران الغرف او في الصفوف او الممرات: نعم ☐ لا ☐
- هل تتضمن النشرات الجدارية (المدرسية) على مواضيع تبين أضرار التدخين: نعم ☐ لا ☐
- وجود كراس دليل مكافحة التبغ في المؤسسات التربوية في المدرسة: نعم ☐ لا ☐
- هل يتم بث إرشادات صحية من قبل الملاك التعليمي حول مضار التدخين أثناء التجمع الصباحي: نعم ☐ لا ☐
- هل يتم إدخال مواضيع توعوية عن مضار التدخين ضمن الدروس (الفنية، الإنشاء، الرياضة، العلوم..الخ) نعم ☐ لا ☐
- هل يلتزم الملاك التعليمي والإداري والخدمي بعدم التدخين أمام التلاميذ: نعم ☐ لا ☐
- هل يتم منع بيع السكائر او مقلدات التبغ داخل المدرسة: نعم ☐ لا ☐
- هل توجد صفحة الكترونية للمدرسة على مواقع التواصل الاجتماعي: نعم ☐ لا ☐
- يدرج اسم الصفحة الالكترونية للمدرسة في هذا المكان ⇦ ☐
- هل يتم نشر التوعية الصحية بأضرار التدخين على الصفحة الالكترونية للمدرسة: نعم ☐ لا ☐
- هل يتم إشراك أولياء أمور التلاميذ بفعاليات مكافحة التدخين(من خلال ما يأتي):
  - ¤ طرح الموضوع في مجالس الآباء والمعلمين: نعم ☐ لا ☐
  - ¤ توجيه رسائل صحية إلى الأهل بعدم التدخين أمام الأطفال: نعم ☐ لا ☐
  - ¤ أي نشاطات أخرى (تذكر): .....
.....
.....

تاريخ تنظيم الاستمارة / / ٢٠

مدير المدرسة

مسؤول مكافحة التبغ او الصحة المدرسية في المركز الصحي

مسؤول وحدة مكافحة التبغ في دائرة الصحة

المداخلات المبسّطة للتحرر من التبغ

في الرعاية الصحية الاولية (5A)

Brief Tobacco Interventions

اليات عمل محددة يتم تطبيقها داخل المركز الصحي تنفيذاً لخطة مكافحة التبغ مدرجة ضمن حزمة الخدمات المقدمة لمراجعي المراكز الصحية الاولية الرئيسية و تهدف الى مايأتي:

- ✓ مساعدة المدخنين على الاقلاع عن التدخين.
- ✓ منع غير المدخنين من الشروع بالتدخين.
- ✓ الحفاظ على غير المدخنين من التعرض لدخان الاخرين (التدخين السلبي)

وتقسم الى قسمين:

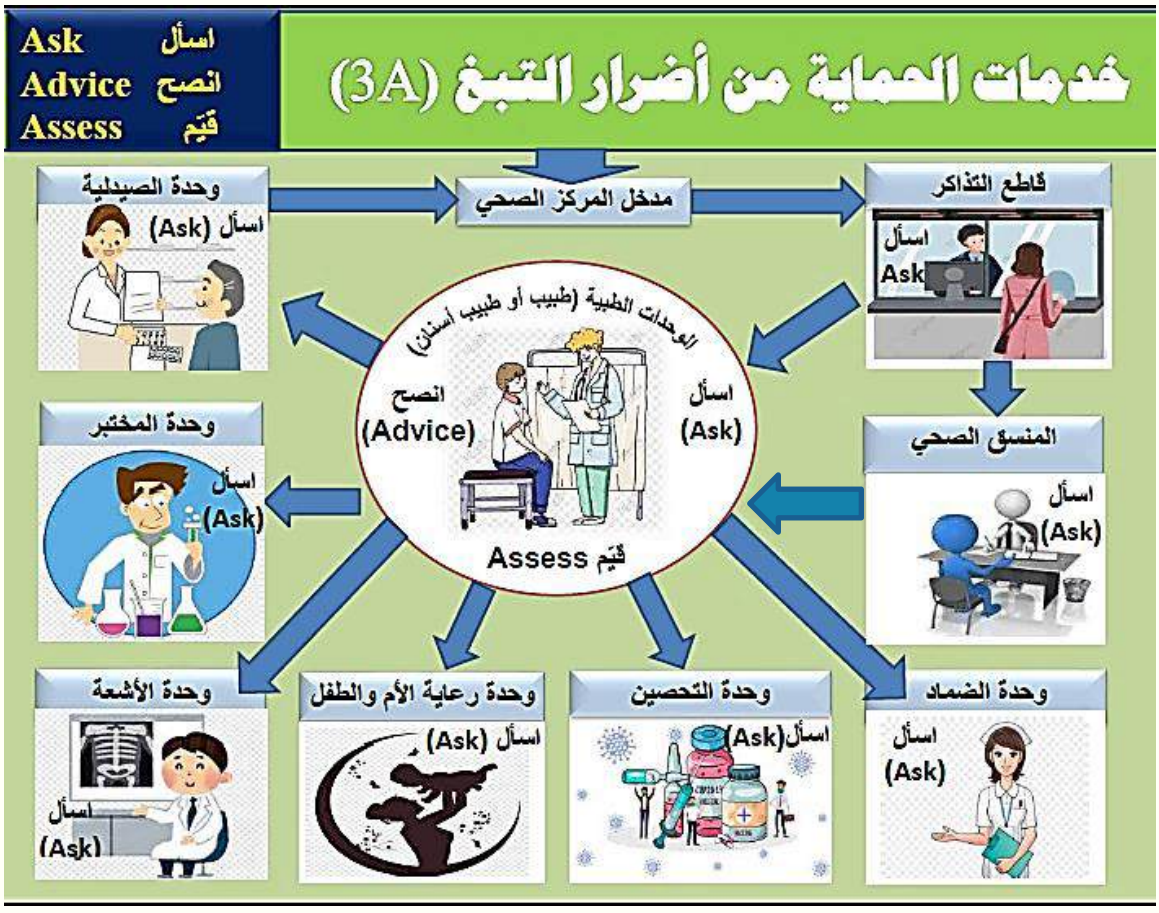
- ✓ **خدمات الحماية من اضرار التبغ (3A)**
- ✓ **خدمات الاقلاع عن التدخين (2A)**



خدمات الحماية من اضرار التبغ (3A)

تشير المادة (14) من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة التبغ (FCTC) الى ضرورة تحديد المدخنين من مراجعي المؤسسات الصحية وتقديم النصيحة لهم (على الاقل) وحثهم على ترك التدخين.

تتمثل هذه الخدمة بتوجيه السؤال (Ask) عن حالة التدخين الى جميع مراجعي مراكز الرعاية الصحية الاولية ممن هم بعمر 18 سنة فأكثر ابتداءً من قاطع التذاكر وانتهاءً بآخر وحدة يمر بها المراجع عند زيارته للمركز الصحي مع توجيه النصيحة (Advice) الدقيقة والمختصرة له من قبل الطبيب المعالج او طبيب الاسنان في الوحدات الطبية والعلاجية والتعرف على مدى استعداده ورغبته بترك التدخين (Assess) وكما موضح ادناه:



يتم تدريب جميع الملاكات الطبية والصحية والادارية في مراكز الرعاية الصحية الاولية الرئيسية على تقديم خدمات الحماية من اضرار التبغ (3A)

خدمات الاقلاع عن التدخين (2A)

تقوم الملاكات المدربة في المركز الصحي الذي يتم اختياره لتقديم هذه الخدمات باستقبال المدخنين الراغبين بترك التدخين وتقديم المساعدة اللازمة لهم وكما يأتي:

- ✓ مناقشة أضرار التدخين الصحية (المباشرة وغير المباشرة) والبيئية والاقتصادية.
- ✓ ملئ استمارة الاقلاع عن التدخين (مرفق رقم -3-) مع حساب كمية النيكوتين التي يتعاطاها المدخن باليوم الواحد وتصنيف المدخنين بحسب درجة الادمان على التبغ باستخدام اختبار فاجر ستروم (Fagerstroem test) (مرفق رقم -4-)
- ✓ قياس نسبة اول اوكسيد الكاربون في الرئة باستخدام جهاز الـ Co analyzer
- ✓ تقديم خدمات المشاورة والارشاد والدعم النفسي (العلاج السلوكي).
- ✓ وصف بدائل (معوضات) النيكوتين المناسبة والعقاقير الضرورية للمدخنين بحسب حاجة كل مدخن وبتوقيع طبيب الوحدة.
- ✓ تنظيم جدول زيارات (مراجعات) وفق جدول زمني محدد للمدخنين لغرض متابعتهم وتشجيعهم على الاستمرار بترك التدخين.



العلاج السلوكي

وهو العلاج القائم على توفير الدعم النفسي للمدخن الراغب بالاقلاع عن التدخين ويتميز بقدرته على تغيير سلوك المقلعين وافكارهم وعواطفهم غير القادرة على التكيّف مع الوضع الجديد مما يؤدي الى مجموعة من المشكلات (مثل الكآبة والقلق وغيرها من المشكلات الصحية) وذلك من خلال ادراجهم في برنامج مكثف يكون بشكل فردي او في اطار جماعي ويتالف من ثلاث مراحل وكما يأتي:

- ✓ **المرحلة الاولى:** مرحلة التهيأة او التحضير من خلال تحديد موعد مناسب للاقلاع عن التدخين مع مراعاة موقف البيئة المصاحبة، الاهل والاصدقاء.
- ✓ **المرحلة الثانية:** مرحلة البدء بالاقلاع عن التدخين من خلال قطع جميع الروابط بين المحفزات والتدخين كالتخلص من الطفّايات والولاعات في البيت ومكان العمل، تجنب العادات المرتبطة بالتدخين، تغيير الروتين اليومي واستبدال الانشطة المعتادة بأنشطة بديلة، مقاومة المغريات، زيادة النشاط البدني، التدريب على تقنيات الاسترخاء، تناول الاعذية الصحية والاكثار من شرب الماء.
- ✓ **المرحلة الثالثة:** مرحلة الادامة من خلال الثبات على قرار الاقلاع عن التدخين وتجنب الزلة (Lapse) وهي ان يشعر تارك التدخين بالضعف والعودة المؤقتة للتدخين لمرة واحدة او اكثر وتجنب الانتكاسة (Relapse) وهي العودة الى حالة التدخين بانتظام كما كان سابقاً.

ماذا يحدث للجسم عند ترك التدخين

- بعد عشرين دقيقة : معدل ضغط الدم وضربات القلب يعودان الى المستوى الطبيعي.
- بعد 12 ساعة : ينخفض مستوى اول اوكسيد الكاربون بالدم وتعود نسبة الاوكسجين للمستوى الطبيعي.
- من 1-3 اسابيع: استعادة التذوق والشم بشكل كبير وزيادة النشاط والجسم خالٍ من النيكوتين.
- من 1-9 اشهر: يقل السعال وتتحسن وظائف الرئة بنسبة % 10 .
- بعد سنة واحدة: يقل خطر الاصابة بامراض القلب الى النصف وتزداد الخصوبة.
- بعد خمس سنوات : يقل خطر الاصابة بسرطان الفم ،المريء ،المثانة وعنق الرحم الى النصف.
- بعد عشر سنوات : يقل خطر الاصابة بسرطان الرئة، البنكرياس والحنجرة الى النصف.
- بعد 15 سنوات: يصبح خطر الاصابة بامراض القلب مساوياً للاشخاص غير المدخنين.

الخطوات العشر للمساعدة على الاقلاع عن التدخين

10 خطوات لمساعدتك على الاقلاع عن التدخين



1. حدد موعداً للاقلاع والتزم به



2. اخبر عائلتك واصدقاءك بانك سوف تترك التدخين للحصول على الدعم النفسي والمعنوي

10 خطوات لمساعدتك على الاقلاع عن التدخين



3. مارس هواية جديدة لتشغل نفسك كالاهتمام بحديقة المنزل او قراءة الصحف والمجلات



4. اشغل فمك بمضغ العلكة او بقطعة من الجزر او بالكرزات والمكسرات

10 خطوات لمساعدتك على الاقلاع عن التدخين



5. اتبع نظاماً صحياً وحافظ على شرب الماء



6. تخلص من الاشياء التي تذكرك باالتدخين كالقداحات ونفاضات السكائر

10 خطوات لمساعدتك على الاقلاع عن التدخين



7. ضع فوائد الاقلاع عن التدخين امام عينيك دائماً وتذكر مردود ذلك على صحتك



8. مارس الرياضة واملأ رئتيك بالهواء النقي

10 خطوات لمساعدتك على الاقلاع عن التدخين



9. مارس اساليب الاسترخاء كالتنفس العميق والتأمل والاستماع للموسيقى



10. اذا لم تنجح في المرة الاولى- حاول مرة اخرى

مرفق رقم -3-

استمارة الإقلاع عن التدخين

الرقم التسلسلي															
تاريخ تنظيم الاستمارة															
الاسم الكامل															
العمر															
الجنس	ذكر				انثى										
الحالة الزوجية	اعزب		متزوج		مطلق		ارمل								
المهنة															
التحصيل الدراسي	امي		يقرء ويكتب		ابتدائية		متوسطة اوثانوية		شهادة عليا						
محل السكن (العنوان الكامل)															
طريقة الإحالة	طوعي		مستشفى		عيادة خاصة		مركز صحي		اخرى (تذكر)						
تاريخ البدء بالتدخين															
فترة التدخين (بالسنين)															
نوع التدخين	سجائر		اركيلة		سيكار		اخرى (تذكر)								
الكمية	سيجارة/يوم		ساعة/يوم		سيكار/يوم										
بمن تأثرت عند بدء التدخين	الاهل		الاقارب		صديق		لااحد		اخرى (تذكر)						
التاريخ المرضي	.....														
هل توجد محاولات سابقة لترك التدخين	نعم		لا		اذا نعم اذكر عدد المرات										
متى تدخن اول سيجارة بعد الاستيقاظ مباشرة؟	بعد ٦٠دقيقة (٠)		٣١-٦٠ دقيقة (١)		٦-٣٠ دقيقة (٢)		خلال ٥ دقائق (٣)								
هل تجد صعوبة في الامتناع عن التدخين في الأماكن المحظورة؟	نعم (١)		لا (٠)												
ما هي السيجارة التي يصعب عليك الامتناع عنها؟	أي سيجارة (٠)		أول سيجارة في الصباح (١)												
كم سيجارة تدخن باليوم؟	١-١٠(٠)		١١-٢٠(١)		٢١-٣٠(٢)		٣٠+(٣)								
هل تدخن في الساعة الاولى من الصباح أكثر من بقية اليوم؟	نعم (١)		لا (٠)												
هل تدخن وانت مريض جداً وملازم للفراش؟	نعم (١)		لا (٠)												
التقدير النهائي لنسبة الادمان	١-٣ :إدمان قليل		٤-٥ :إدمان متوسط		٦-١٠ :ادمان عالي										
قياس نسبة اول اوكسيد الكاربون(PPM)															
عقار البوبروبيون (zyban)	تاريخ الاعطاء				الكمية والجرعة										
تاريخ ترك التدخين															
المتابعة الاولى	التاريخ				قياس CO										
Patch															

Lozenges					
Gum					
عقار البوبروبيون (zyban)					
المتابعة الثانية	التاريخ		قياسCO		
Patch					
Lozenges					
Gum					
عقار البوبروبيون (zyban)					
المتابعة الثالثة	التاريخ		قياسCO		
Patch					
Lozenges					
Gum					
عقار البوبروبيون (zyban)					
المتابعة الرابعة	التاريخ		قياسCO		
Patch					
Lozenges					
Gum					
عقار البوبروبيون (zyban)					
المتابعة الخامسة	التاريخ		قياسCO		
Patch					
Lozenges					
Gum					
عقار البوبروبيون (zyban)					
المتابعة السادسة	التاريخ		قياسCO		
Patch					
Lozenges					
Gum					
عقار البوبروبيون (zyban)					

المتابعة السابعة	التاريخ	قياس CO	النتيجة		
			مقلع		منتكس
المتابعة الثامنة	التاريخ	قياس CO	النتيجة		
			مقلع		منتكس
المتابعة التاسعة	التاريخ	قياس CO	النتيجة		
			مقلع		منتكس
المتابعة العاشرة	التاريخ	قياس CO	النتيجة		
			مقلع		منتكس

ملاحظات:

١) تاريخ المتابعة الاولى بعد سبعة ايام من تاريخ الزيارة الاولى
٢) الفترة الزمنية بين متابعة واخرى اسبوعين
٣) المتابعة السابعة تكون بعد شهر من المتابعة السادسة
٤) المتابعة الثامنة بعد شهرين من المتابعة السابعة
٥) المتابعة التاسعة بعد ثلاثة اشهر من المتابعة الثامنة
٦) المتابعة العاشرة بعد ستة اشهر من المتابعة التاسعة

مرفق رقم -4-

اختبار فاجر ستروم لقياس الادمان على النيكوتين
من 0-3 تدخين ضعيف
من 4-6 تدخين متوسط
(في حالة جمع سبعة درجات او اكثر فهذا مؤشر على الادمان)

ت	السؤال	الجواب	الدرجة
١	متى تدخن اول سيجارة بعد ان تستيقظ من النوم صباحا؟	خلال ٥ دقائق ٦-٣٠ دقيقة ٣١-٦٠ دقيقة بعد ٦٠ دقيقة	٣ ٢ ١ ٠
٢	هل تجد انه من الصعوبة ان تمتنع عن التدخين في الاماكن التي يمنع فيها التدخين (مثل المساجد، الكنائس، المكتبات..الخ)؟	نعم كلا	١ ٠
٣	اي سيجارة تكره ان تتخلى عنها؟	اول سيجارة في الصباح باقي السجائر الاخرى	١ ٠
٤	كم سيجارة تدخن يوميا؟	١٠ او اقل ١١- ٢٠ ٢١- ٣٠ ٣١ او اكثر	٠ ١ ٢ ٣
٥	هل تدخن خلال الساعة الاولى بعد استيقاظك في الصباح اكثر من باقي الوقت؟	نعم كلا	١ ٠
٦	هل تدخن عندما تكون مريض جدا وطريح الفراش معظم النهار؟	نعم كلا	١ ٠

انواع واشكال الادوية والعقاقير المستخدمة عالمياً في الاقلاع عن التدخين

- Nicotine Patches لصقات جلدية
  - 16hr: 25, 15, 10 & 5 mg
  - 24hr: 21, 14 & 7 mg
- Nicotine Gum 2 & 4 mg علكة
- Nicotine Microtabs 2 mg اقراص صغيرة
- Nicotine Lozenges 1, 2 & 4 mg اقراص المص
- Nicotine Inhalators مستنشقات
- Nicotine Nasal Spray بخاخ انفي
- Zyban (Bupropion) 150 mg زايبان
- Champix (Varenicline) جامبكس

الآثار التي يعاني منها المدخن عند ترك التدخين

- Gastro-intestinal discomfort
- Increased appetite, weight gain
- Anxiety (short term)
- Depressed Mood (short term)
- Craving
- Difficulty concentrating
- Irritability

- اضطرابات المعدة والامعاء
- زيادة الشهية للطعام مع زيادة الوزن
- القلق (لفترة قصيرة)
- الاكتئاب (لفترة قصيرة)
- التوق أو الحنين للسيجارة
- صعوبة التركيز
- الهيجان

النيكوتين

- Nicotine → very toxic.
- No antidote known.
- When swallowed: very slow uptake in stomach.
- Overdose: activates chemosensors in medulla (vomiting center) → vomiting

النيكوتين مادة سامة للغاية وليس لها ترياق (مضاد سمي) ويمتص بصورة بطيئة جدا في المعدة
يحفز اجهزة الاستشعار الكيمياوية في الدماغ مما يؤدي الى التقيء المستمر
الجرعة القاتلة من النيكوتين 60 ملغرام

علامات التسمم بالنيكوتين

Nicotine – symptoms of poisoning

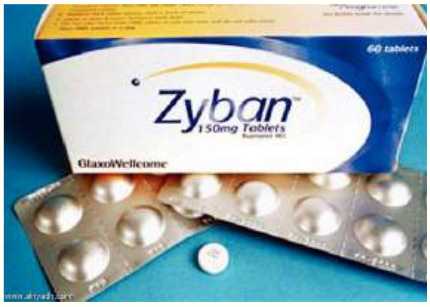
- nausea, vomiting
- cold sweat, salivation
- abdominal pain
- impaired vision and hearing
- confusion
- headache
- fatigue
- breath probleams, reduces puls, collapse
- → death by breathing arrest after few minutes

- غثيان مع تقيء
- تعرق مع برودة الجلد وزيادة في افراز اللعاب
- الام البطن
- ضعف البصر والسمع
- تشويش وارتباك
- صداع
- تعب واعياء
- مشاكل تنفسية، تباطؤ النبض ثم انهيار
- توقف التنفس وقد يؤدي الى الموت

Bupropion (Zyban); 150mg

- Non-nicotine drug,

  First used as an antidepressant
- Works directly to block the reward pathway in brain and therefore reduce the pleasure in smoking and withdrawal craving
- Start treatment 1-2 weeks before stopping smoking.
- Treatment continued for 8 weeks.
- Initial dose - 1 tablet for the first 6 days, then 2 tablets daily from the seventh day to the end of course.



Contraindications

Current or previous seizure disorder, bulimia (eat excessive amounts of food) or anorexia, severe liver disease, history of bipolar disorder, pregnancy/breast feeding, children < 18 years.

البوبروبيون (زايبان) 150 ملغم

- ✓ ليس من بدائل النيكوتين
- ✓ من مضادات الكآبة
- ✓ يعمل بصورة مباشرة على الدماغ فيقلل من النشوة او المتعة التي يشعر بها المدخن ويقلل من فرص التوق والرغبة في ممارسة التدخين اثناء فترة الانقطاع
- ✓ يعطى قبل تاريخ ترك التدخين بـ (1-2) اسبوع
- ✓ يستمر اعطاؤه للمدخن لمدة (8) اسابيع
- ✓ الجرعة الاولية حبة واحدة يوميا لمدة (6) ايام ثم تزداد الجرعة من اليوم السابع لغاية نهاية العلاج لتصبح حبتان يوميا (صباحا ومساءً)

موانع الاستعمال

الصرع، شراهة الطعام، فقدان الشهية، امراض الكبد، اضطرابات ثنائية القطب (مثل انفصام الشخصية)، الحامل والام المرضع ولايعطى الدواء لمن هم تحت سن الـ(18) سنة

Nicotine Skin Patch

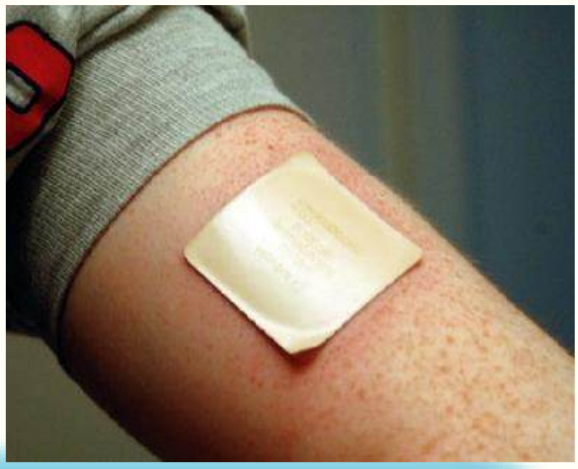
24 hours, 14 mg, 21mg (The appropriate concentration of the patch is chosen according to the number of cigarettes smoked by the smoker per day,14 mg was given if the number of smoked cigarettes is less than 10/ day, while 21 mg was given if the number of smoked cigarettes is more than 10/day)

How it works:

- Delivers a steady dose of nicotine to bloodstream via skin.
- Peak levels reached 2-6 hours after applying the patch.
- Absorption rate – approx. 1 mg per hour.

How it is used

- One patch a day, on a dry and hairless spot
- Rotate site daily
- Duration of treatment 8-12 weeks



لصقات النيكوتين الجلدية (24 ساعة/ 14 ملغم، 21 ملغم)

- ✓ يتم اختيار التركيز المناسب للّصقة بحسب عدد السجائر التي يدخنها المدخن يومياً (14 ملغم اذا كان عدد السجائر اقل من 10 و 21 ملغم اذا كان عدد السجائر اكثر من 10)
- ✓ تطلق جرعة ثابتة من النيكوتين الى مجرى الدم عن طريق الجلد
- ✓ تصل الى أعلى مستوى لها في الدم بعد 2 – 6 ساعات بعد وضعها على الجلد
- ✓ معدل الامتصاص (1) ملغم / ساعة تقريباً
- ✓ لصقة واحدة يومياً على جلد جاف ومنطقة خالية من الشعر
- ✓ ينبغي تغيير مكان اللصقة بصورة يومية
- ✓ يستمر العلاج باللصقات من (8 – 12) اسبوع

موانع الاستعمال

يفضل عدم استخدام لصقات النيكوتين للمدخنين في حالة اصابتهم بامراض جلدية مزمنة كالاكزما والصدفية والفقاع الجلدي وغيرها من الامراض التي تشكل نسبة انتشارها مساحة واسعة من جلد الشخص المدخن.

Nicotine Gum

2mg, 4mg chewing gum (The appropriate concentration of chewing gum is chosen according to the number of cigarettes smoked by the smoker per day (2 mg if the number of cigarettes is less than 25 cigarettes, and 4 mg if the number of cigarettes is more than 25 cigarettes).

How it works

- Each piece delivers nicotine to bloodstream through buccal mucosa
- Peak levels reached in about 30 minutes
- Absorption rates – approx. 0.9mg per 2mg piece

How it is used

- One piece every 1-2 hours for 6 weeks, then 1 piece every 2-4 hours for 3 weeks, then 1 piece every 4-6 hours for 3 weeks
- 10-15 pieces a day – build steady dose nicotine
- Special chewing technique
- Duration of treatment 8-12 weeks



علكة النيكوتين (2 ملغم، 4 ملغم)

- ✓ يتم اختيار التركيز المناسب للعلكة بحسب عدد السجائر التي يدخنها المدخن يومياً (2 ملغم اذا كان عدد السجائر اقل من 25 سيجارة، و 4 ملغم اذا كان عدد السجائر اكثر من 25سيجارة)
- ✓ كل قطعة تطلق النيكوتين الى مجرى الدم عن طريق بطانة الفم
- ✓ تصل الى أعلى مستوى لها في الدم بغضون (30) دقيقة
- ✓ معدل الامتصاص (0.9) ملغم/ قطعة
- ✓ تؤخذ قطعة واحدة كل 1-2 ساعة لمدة 6 اسابيع، بعدها قطعة واحدة كل 2-4 ساعة لمدة 3 اسابيع، بعدها قطعة واحدة كل 4-6 ساعة لمدة 3 اسابيع
- ✓ تعطى (10 – 15) قطعة/ يوم للحصول على جرعة ثابتة من النيكوتين
- ✓ يستمر العلاج بعلكة النيكوتين من (8 – 12) اسبوع

Nicotine Lozenges, 2 mg, 4mg

What it is

Sugar-free compressed tablet

How it works

Delivers nicotine to bloodstream through buccal mucosa

How it is used

- The concentration of tablets given to the smoker is determined according to the first cigarette smoked by the smoker in the morning (if the first cigarette smoked during the first half hour after waking up, is given a dose of 4 mg while if the first cigarette is smoked half an hour after waking up, a dose of 2 mg was given)
- 1 lozenge every 1-2 hours for 6 weeks, then 1 lozenge every 2-4 hours for 3 weeks, then 1 lozenge every 4-8 hours for 3 weeks.
- Placed in mouth & allowed to dissolve 20/30 minutes
- Moved round mouth
- Duration of treatment – at least 12 weeks



اقراص المص (2 ملغم، 4 ملغم)

- ✓ حبوب مضغوطة خالية من السكر تطلق النيكوتين الى مجرى الدم عن طريق بطانة الفم
- ✓ يتم تحديد تركيز الاقراص الممنوحة للمدخن بحسب اول سيجارة يدخنها المدخن في الصباح (اذا كانت السيجارة الاولى خلال اول نصف ساعة بعد الاستيقاظ تعطى جرعة 4 ملغم واذا كانت السيجارة الاولى بعد نصف ساعة من الاستيقاظ تعطى جرعة 2 ملغم)
- ✓ يؤخذ قرص واحد كل (1-2) ساعة لمدة 6 اسابيع، ثم قرص واحد كل 2-4 ساعة لمدة 3 اسابيع، ثم قرص واحد كل 4-8 ساعة لمدة 3 اسابيع.
- ✓ يحرك داخل الفم ويترك ليذوب بعد (20-30) دقيقة
- ✓ تستغرق فترة العلاج (12) اسبوع

مشروع المدارس المناهضة للتدخين

تعكف وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية على تطوير وتوسيع العمل بمشروع **مدارس مناهضة للتدخين** في المدارس الابتدائية والذي يهدف الى منع التلاميذ من الشروع بالتدخين وحمايتهم من التعرض للتدخين السلبي من خلال ما يأتي:

- ✓ زيادة الوعي الصحي للتلاميذ والكوادر التربوية وأولياء الأمور حول الأضرار الناجمة عن تعاطي التبغ والتعرض لدخانه.
- ✓ مساعدة التلاميذ على اكتساب المعارف اللازمة لتغيير توجهاتهم نحو نبذ ظاهرة التدخين والدفاع عن حقهم باستنشاق هواء نقي خال من دخان التبغ.

متابعة اليات عمل المشروع

يتم متابعة المشروع من خلال الزيارات الميدانية للمدارس المشمولة من قبل مسؤول الصحة المدرسية في المركز الصحي ضمن الرقعة الجغرافية للمدرسة وباشراف مسؤول وحدة مكافحة التبغ وشعبة الصحة المدرسية في دائرة الصحة والقطاع (بمعدل زيارة واحدة على الاقل في كل من الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني) وفقاً لاستمارة المتابعة الميدانية للمشروع والمشار اليها انفاً.
ملاحظة: تفاصيل اكثر عن المشروع وردت ضمن دليل مكافحة التبغ في المؤسسات التربوية



رسائل صحية عن التدخين

- ❖ قانون مكافحة التدخين.. حماية لكم ولأبنائكم من مخاطر التدخين.
- ❖ قانون مكافحة التدخين يؤمن لنا بيئة صحية خالية من الملوثات.
- ❖ التدخين في الاماكن العامة المغلقة يضر بالآخرين ويعرضهم لخطر الاصابة بأمراض فتاكة ومخالفة يحاسب عليها القانون.
- ❖ التدخين في وسائط النقل يزعج الاخرين ويصادر حقهم في استنشاق هواء نقي ومخالفة يحاسب عليها القانون.
- ❖ التدخين في البيت يعرض الأطفال لخطر الاصابة بأمراض مميتة.
- ❖ تعاطي الاحداث للتدخين يعرضهم لخطر الاصابة بأمراض قاتلة.
- ❖ طالبوا بحقوقكم في استنشاق هواء نقي بعيدا عن دخان الاخرين.
- ❖ عزيزي المدخن: ان شركات انتاج التبغ تحاول اصطياد زبائن جدد بدلاً من أولئك الذين ماتوا بسبب التدخين... فلاتكن واحدا منهم.
- ❖ عزيزتي الام الحامل: التدخين يضر بصحتك وصحة جنينك... ننصحك بالابتعاد عنه.
- ❖ عزيزي المدخن: ينتهي حقك بالتدخين عندما يبدأ حق الاخرين باستنشاق هواء نقي.
- ❖ عزيزي المدخن: تجنب التدخين لأنه سبب مباشر في الكثير من الامراض القاتلة.
- ❖ انتبه اخي المدخن: ان السيجارة الواحدة تقلل حوالي (7) دقائق من عمرك.
- ❖ تحتوي السيكارة الواحدة على اكثر من (7000) مادة كيمياوية سامة و مسرطنة.
- ❖ ان تدخين الاركيلة (الشيشة) لمدة ساعة واحدة يعادل تدخين (100-200) سيجارة.
- ❖ يقتل التدخين واحداً من كل اثنين من متعاطيه.
- ❖ استبدلوا سجائركم بانفاس اطفالكم... استنشقوهم فهم الحياة.
- ❖ التبغ قاتل طليق... فلنحمي براءة اطفالنا منه.
- ❖ لاتدعوا التدخين يسرق انفاسكم ولحظات حياتكم الجميلة.

المصادر

- اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة التبغ
- استراتيجية الـ (MPOWER) العالمية في مجال مكافحة التبغ
- النشرات والاصدارات لاقليم شرق المتوسط/ منظمة الصحة العالمية
- التقرير العالمي حول وباء التبغ لعام 2023 الصادر عن منظمة الصحة العالمية
- مركز الوقاية والسيطرة على الامراض/ اطلنطا (CDC)
- وزارة التخطيط/ الجهاز المركزي للاحصاء
- استراتيجية الوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية
- مسح عوامل خطورة الامراض غير الانتقالية لعام 2015
- المسح العالمي للشباب حول استخدام التبغ في العراق للفئة العمرية (13-15) سنة لعام 2019
- الخطة الوطنية لمكافحة التبغ
- كراس حقائق ومعلومات عن التبغ/ المملكة العربية السعودية



رقم الايداع في المكتبة الوطنية العراقية

2900 **لسنة** 2024